EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67830
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-21 13:43:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PATRICIO ANDRES FUENTES BAHAMONDES			**RUN**	: 11.111.422-6
F.Nac	: 07-06-1967	**Edad**	: 56 AÑOS, 1 MES	**Género**	: Masculino
Dirección	: EL CARBON			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 996659376		
Fecha Ingreso	: 14-07-2023	**Fecha Egreso**	: 2023-07-21 13:43:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

LEUCEMIA
NEUMONIA POR STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.8-OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

ALERGIAS: NO AM:LEUCEMIA QTT VO, HTA

Paciente acude a urgencias el día 14/07 refiere inicio de sintomatología hace 4 días presentando aumento de temperatura corporal cuantificada 38.8, asociado a accesos de tos intermitente. humeda, escasa secreción, verde-amarillenta. Acorde a relato, se asocia a rinorrea, cefalea holocraneana.
Leve CEG, mialgia generalizada leve, disnea a moderados esfuerzos.
Tac de torax muestra opacidades en vidrio esmerilado en el parénquima pulmonar derecho sugerente de compromiso inflamatorio infeccioso, cardiomegalia asociado a signos vasculares ipertensión pulmonar.
Se ingresa para manejo, se realiza cultivo de secreción bronquial que muestra + para STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA, por lo que recibe tratamiento con cotrimoxazol y ceftriaxona, con evolución favorable.
Fue evaluado por especialista broncopulmonar que indica control de tac el cual muestra significativa regresión del infiltrado intersticio alveolar con densidad esmerilado.
Prominentes adenopatías mediastínicas, ya visibles en examen anterior. Considerar dentro del diagnóstico diferencial una neumopatía intersticial. Signos de edema intersticial en grado leve. Hipertensión pulmonar. Nódulos espiculados en lóbulo inferior derecho. Considerar dentro del diagnóstico diferencial que correspondan a lesiones broncogénicos primarias.
Familiar refiere que ya sabía de estos nódulos y que estaba en control por broncopulmonar de HHM.
Paciente en mejor estado, parámetros inflamatorios bajos, tac con infiltrado en regresión por lo que se decide continuar antibioticoterapia de forma ambulatoria y control por especialidad dentro de 1 mes.

PLAN DE MANEJO:

Control por poli broncopulmonar.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo

2. Cotrimoxazol 1 comp dia por 11 días
3. Ceftriaxona 2 gr dia por 11 día EV
4. Omeprazol 20mg 1 c dia por 15 días
5. Bromuro de ipratropio 2 puff c 6hrs x 15 días
6. Losartan 50mg 1 c 12hrs
7. Atorvastatina 40mg vo
8. Medicación para leucemia de forma habitual

Mariana Panique Pedraza
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO